

01 - 01-sémiologie dermatologique : Lésions élémentaire - Pr. Hocar

(0:00 - 0:24)

Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la simiologie dermatologique. Les objectifs de cet enseignement sont comme il suit. Savoir réaliser un interrogatoire en dermatologie, puis planifier un examen dermatologique, ensuite définir les différentes lésions élémentaires et au final connaître le mécanisme histologique des lésions élémentaires.

(0:25 - 0:46)

Comment s'organise l'architecture et la structure de la peau ? Ce qu'il faut savoir c'est que la peau représente l'organe le plus lourd du corps humain et le plus étendu. C'est un organe complexe, richement vascularisé et énérvé. La peau humaine est constituée de la surface à la profondeur de trois types de tissus, l'épiderme, l'oderme et l'hippoderme.

(0:47 - 1:18)

L'épiderme est un épithélium pavimenteux, pluristratifié, kératinisé et pigmenté, constitué de plusieurs couches successives. D'abord la couche basale ou le stratum basale, la couche intermédiaire au stratum spinosum au corps muqueux de Malpighi ou aussi appelée la couche hypineuse, la couche granuleuse au stratum granulosum et en final la couche cornée au stratum cornue. L'oderme s'organise en deux zones anatomiques différentes.

(1:19 - 1:59)

L'oderme superficiel ou l'oderme papillaire contient le réseau vasculaire superficiel et les terminisants sensitifs et l'oderme moyen ou l'oderme réticulaire riche en fibroblastes qui synthétise le collagène et l'élastine qui mènent dans la matrice extracellulaire aux substances fondamentales englobant le réseau vasculaire et les annexes. Et puis à la fin on a l'hippoderme organisé en lobules adipeux formés d'adipocytes et de septa interlobulaires fait du tractus conjonctif véhiculant les vaisseaux et les nerfs. L'interrogatoire en dermatologie doit spécifier le sexe parce qu'on a des dermatoses héréditaires liées au sexe.

(1:59 - 2:20)

Il doit spécifier l'âge parce qu'il y a des dermatoses spécifiques à certaines périodes de vie comme les dermatoses néonatales. La profession parce qu'on a des dermatoses professionnelles comme l'eczéma des cimentiers. Il doit chercher une consanguinité, par exemple certaines maladies héréditaires comme l'exeroderma pigmentosum et l'exectio sont favorisées par la consanguinité.

(2:21 - 2:48)

Il doit aussi spécifier l'origine ethnique et géographique notamment dans certaines maladies infectieuses comme la leishmaniose cutanée et la lèpre. Il doit spécifier les antécédents personnels et familiaux par exemple un terrain d'atopie qui pourrait favoriser l'urticaire, les conjunctivites allergiques, l'asthme. Spécifier si le patient est porteur d'un diabète, d'une tuberculose, d'une notion de contagivité dans certaines maladies comme la gale qui est une dermatose parasitaire très contagieuse.

(2:51 - 3:24)

L'anamnèse doit rechercher des signes fonctionnels comme le prurite dans le cadre d'une gale ou dans le cadre d'un prurite chronique de cause interne. La douleur dans le cadre d'un zona ou d'une éruption cutanée. Et bien sûr, il faut spécifier les modalités évolutives de l'éruption, son mode de début, ce que c'est localisé ou défilé, est-ce que c'était brutal ou progressif, l'aspect initial des lésions élémentaires, le mode d'extension de chaque élément et l'évolution générale de l'éruption, est-ce que c'est une évolution permanente ou il se fait par poussée ou rémission.

(3:24 - 3:41)

Et bien sûr, il faut au final spécifier les traitements appliqués sur ces lésions. Après l'anamnèse, on passe à l'examen physique et on se pose trois grandes questions. Observer, comment observer et comment analyser ce qu'on observe.

(3:42 - 3:56)

On va commencer par la première question, observer. On va examiner la peau, les muqueuses et les fanères, on veut dire par fanères, les cheveux et les ongles. Passons maintenant à la deuxième question, comment observer.

(3:57 - 4:22)

Il faut observer le patient nu avec un bon éclairage, il faut privilégier l'éclairage avec lumière de jour. Le clinicien doit être muni de gants, compléter l'inspection par la palpation à la recherche d'une infiltration, d'une induration. Il peut s'aider d'une loupe, d'un dermatoscope, d'un verre de montre pour la vitre aux pressions, d'une curette pour un grattage doux, de l'examen aux lumières de houde.

(4:22 - 4:42)

C'est une émission de rayons ultraviolets d'une longueur d'onde lambda de 360 nanomètres permettant d'observer la fluorescence de certains champignons ou d'analyser certaines dyschromies. Passons maintenant à la troisième étape, c'est comment analyser ce qu'on observe. On va commencer par la nature et la description de la lésion élémentaire.

(4:42 - 5:01)

On va analyser ces lésions élémentaires, leur consistance, leur couleur, leur infiltration et puis

on va voir le groupement de ces lésions élémentaires et puis leur topographie. On va commencer par la première lésion élémentaire, c'est la macule. C'est défini comme une tâche sans relief ni infiltration.

(5:01 - 5:10)

C'est une simple modification de la couleur de la peau. Et là, on existe plusieurs types. Le premier type, c'est les macules érythémateuses.

(5:10 - 5:26)

Ce sont des lésions de couleur rose ou rouge s'effaçant à la vitre aux pressions. Et le mécanisme, c'est une hyperémie inflammatoire du derme superficiel et moyen. La croissance de plusieurs macules érythémateuses constitue l'érythème.

(5:26 - 5:42)

On peut parler d'un érythème localisé au défus. Cette photo montre un patient qui présente un érythème morbidiforme fait d'éléments lenticulaires conflants par plage avec des espaces de possènes. Cet aspect, on le voit souvent dans la rougeole et dans la rubéole.

(5:43 - 5:59)

Un autre patient qui présente un érythème scarlatiniforme qui est fait de placards et de nappes avec peu ou pas d'intervalles de possènes. Cet aspect, on le voit dans la scarlatine. Cette photo montre une jeune patiente qui présente un érythème roséoliforme.

(6:00 - 6:15)

C'est un érythème constitué de macules roses pâles non conflantes, à peine visibles. Et cet aspect se voit au cours de la syphilis secondaire et la roséole infantile. Après les macules érythémateuses, on va voir les macules vasculaires.

(6:15 - 6:33)

Ils sont définis comme des lésions qui s'effacent à la vitre pression et qui sont dues à une dilatation vasculaire dermique. Cet aspect se voit au cours des télangiectasies et les angioplans. Cette photo montre des télangiectasies ou des ectasies vasculaires qui sont des macules vasculaires.

(6:34 - 6:49)

Troisième type de macules, ce sont les macules pleuporiques. Ce sont des macules qui ne s'effacent pas à la vitre pression et le mécanisme, c'est une extravasation de sang dans le derme. Toujours dans les macules, on va voir les macules pigmentés.

(6:50 - 7:05)

Ce sont des lésions brun clair au foncé, violacé, noir violacé. Le mécanisme est une accumulation de pigments le plus souvent mélaniques dans l'épiderme ou dans le derme. La macule pigmentée peut se voir au cours d'un érythème pigmenté fixe ou au cours des syphilis.

(7:07 - 7:41)

Une autre forme de macule, ce sont les macules achromiques qui sont définis comme des macules clairs qui sont dus à une diminution de la quantité de la mélanine épidermique et d'exemple type, c'est le vitiligo. Après avoir vu les lésions pleines sans relief ni infiltration qui sont les macules, on va voir maintenant les papules qui sont définis comme des ulvures saillantes, circonscrites, solides, ne contenant pas de liquide et d'un diamètre inférieur à 1 cm. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ce sont des lésions de molluscum contagiosum qui sont des papules.

(7:42 - 8:07)

On peut distinguer trois types de papules, les papules épidermiques, les papules dermiques et les papules dermoépidermiques. On va commencer par les papules épidermiques et on en distingue deux sous-types. D'abord, les papules épidermiques secondaires à un effacement de la couche cornée comme les hyperkeratoses et les papules épidermiques avec hyperplasie de la couche de Malpighi ou hyperacanthose.

(8:08 - 8:27)

L'exemple type de papules épidermiques, c'est les verrues vulgaires comme le montre cette photo. Deuxième type, ce sont les papules dermiques qui sont subdivisés en trois formes. D'abord, les papules dermiques odimateuses qui sont dues à une séro-oxydation dermique, lésions qu'on voit au cours d'une urticaire.

(8:28 - 9:20)

Deuxième sous-type de papules dermiques, ce sont les papules dermiques par dépôt de substances anormales, lésions qu'on voit au cours d'une amylose cutanée. Troisième type de papules dermiques, ce sont les papules dermiques cellulaires qui sont dues à une infiltration superficielle du derme par des cellules inflammatoires, aspect qu'on retrouve au décours d'une lèvre. On a vu les papules épidermiques, les papules dermiques, soit par séro-oxydation, soit par dépôt de substances anormales ou par infiltration cellulaire.

Maintenant, nous allons voir les papules dermoépidermiques qui sont dues à une hyperplasie épidermique et à un infiltrat dermique. L'exemple type, c'est le liquide plomb. Après avoir vu les lésions sans relief, sans infiltration, qui sont les macules, et puis on a vu les lésions avec relief, mais à contenu solide, qui sont les papules.

(9:20 - 9:39)

Maintenant, on va voir les éruptions en relief à contenu liquidien. D'abord, les vésicules, puis les bulles et les pustules. Tout d'abord, on va voir les vésicules qui sont un soulèvement circonscrit de l'épiderme dont la taille est entre 1 et 3 mm, qui contiennent une sérosité claire.

(9:39 - 10:02)

On distingue deux sous-types de vésicules. D'abord, les vésicules intraépidermiques, chose qu'on voit au décours d'une varicelle, d'un herpès ou d'un eczéma, et les vésicules sous-épidermiques qu'on voit au cours d'une dermatite herpétiforme. Cette photo montre une patiente atteinte d'une varicelle et on voit les lésions élémentaires vésiculeuses à contenu clair éparpillées sur son front.

(10:03 - 10:38)

Deuxième lésion élémentaire à contenu liquidien, ce sont les bulles qui sont définies comme un soulèvement circonscrit de l'épiderme avec un contenu clair, séropurulent ou hémorragique et dont la taille est supérieure à 0,5 cm. On distingue des bulles intraépidermiques comme le pinfigus ou des bulles sous-épidermiques comme la pinfiguide bulleuse. En cas de dermatose bulleuse, il faut chercher le signe de Nikulski qui est le décollement bulleux obtenu par le frottement de la peau, apparemment sain et il est positif au cas de pinfigus vulgaire ou du syndrome de Leyen.

(10:38 - 11:08)

On arrive au troisième type de lésions élémentaires à contenu liquidien, ce sont les pustules. Elles sont définies comme un soulèvement circonscrit de l'épiderme qui contient du pus et dont la taille est de quelques millimètres à 0,5 cm. On peut distinguer les pustules folliculaires qui sont des lésions pustuleuses centrées par un poil qu'on voit au cours d'une folliculite généralement bactérienne ou des pustules non folliculaires qu'on peut voir au cours d'une maladie inflammatoire comme le psopustuleux.

(11:09 - 11:32)

Cette photo montre des pustules folliculaires d'origine bactérienne chez un patient diabétique. Par contre, sur cette photo on voit des pustules non centrées par des poils, on peut parler de pustules non folliculaires d'origine inflammatoire qu'on peut voir au cours d'un psoriasis pustuleux. Un autre aspect de lésions élémentaires cutanées, ce sont les infiltrats hypodermiques.

(11:32 - 11:54)

On peut en distinguer les nodules, les nouilles, les gommès. Les nodules sont définis comme des élevures rondes saillantes dont la taille est supérieure à 1 cm et qui sont dues à une augmentation de la masse dermique et hypodermique par prolifération cellulaire bénigne ou maligne. On peut voir cet aspect au cours d'un névus dermique ou défibrant.

(11:55 - 12:43)

Comme vous pouvez voir sur ces deux photos, ce sont des nodules qui révèlent un névus ou d'œdème neurofibrillaire. Les papules ou les nodosités sont définies comme des éruptions fermes, persistantes, érythémateuses ou de coloration normale et qui sont dues à un infiltrat cellulaire dermo-hypodermique, septal et ou lobulaire, et l'exemple type, c'est l'érythème noueux. Cette photo montre un aspect d'érythème noueux.

C'est une dermatose qui privilégie plus les membres inférieurs et qui peut se voir dans les suites d'une infection streptococcique. Toujours dans les infiltrats cutanés, on va voir maintenant les gommes qui sont définies comme des nodules qui se ramollissent et puis se fistulisent. L'exemple type de ces gommes, c'est la tuberculose cutanée ou les gommes tuberculeuses.

(12:45 - 13:16)

Les végétations cutanées, ce sont des excroissances papillomateuses qui donnent un aspect en chou-fleur à la peau et sont dues à une hyperplasie à la fois de l'épiderme et du derme et peuvent révéler des cancers cutanés comme le carcinome épidermoïde. Cette photo montre une lésion ulcéro-végétante du scalp révélant un carcinome épidermoïde. Les kératoses cutanées, ce sont des lésions sèches, épaisses, en relief sur la peau voisine et qui se voient au cours d'une kératodermie plantaire.

(13:17 - 13:33)

Les verrucosités, ce sont des végétations à surface kératosique sèche. Cette lésion élémentaire peut se voir au cours d'une tuberculose verruqueuse. Les squames cutanées sont définies comme des lamelles de couche cornée qui se détachent de l'épiderme.

(13:34 - 14:05)

On peut en distinguer les squames scarlatiniformes, ce sont des squames à grands longs bouts, aspects qui se voient au cours d'une scarlatine ou d'une toxidermie médicamenteuse. Deuxième aspect de squamme, ce sont les squames pityriasiformes, ce sont des squames fines, petites, blanchâtres, qui se voient au cours d'un pityriasis versicolore. Troisième aspect de squamme, ce sont les squames psoriasiformes, ce sont des squames brillantes, micassées et nombreuses, aspects qui se voient particulièrement lors d'un psoriasis.

(14:05 - 14:32)

Quatrième aspect de squamme, ce sont les squames ichthyosiformes, qui donnent un aspect d'écaille de poisson, aspects retrouvés dans l'ichthyose congénitale qui est une dermatose héréditaire. Les croûtes cutanées sont définies comme un dessèchement superficiel d'un exsudat d'une sécrétion d'une nécrose ou d'une hémorragie cutanée, aspects retrouvés dans l'impétigo. Cette jeune patiente présente des croûtes jaunâtres révélant une surinfection

cutanée.

(14:33 - 14:57)

On arrive maintenant aux pertes de substances cutanées et on peut en distinguer la fissure, l'érosion, l'ulcération et la gangrène. La fissure cutanée est définie comme une érosion superficielle linéaire qui cicatrise sans séquelles. L'érosion est définie comme une solution de continuité épidermique qui guérit sans cicatrices et qui se voit au cours d'un chancre séphilitique.

(14:58 - 15:29)

Alors que l'ulcération c'est une perte de substances profondes de l'épiderme, du derme, superficiel et profond et qui cicatrise avec séquelles qui se voit au cours d'un ulcère de jambe. La gangrène cutanée est définie comme une nécrose tissulaire donnant cet aspect noirâtre à la peau et il est dû à une hypo-vascularisation. Les atrophies cutanées sont définies comme un amincissement de la peau qui lui donne cet aspect lisse et nacré et qui laisse entrevoir les vaisseaux du derme superficiel.

(15:29 - 16:12)

Quant à l'appui qu'est le derme, il est défini comme l'association d'une atrophie cutanée, de téléangiectasie et des troubles de la pigmentation. L'exemple des atrophies et de poéculodermie, c'est la possinie. Cette photo montre un aspect atrophique chez un patient âgé et qui laisse entrevoir les vaisseaux du derme.

Cette photo montre une patiente qui présente une atrophie cutanée cupuliforme de la joue secondaire à une paniculite lupique qui est une forme de lupus cutané. On arrive maintenant à la sclérose cutanée qui est définie comme une induration de la peau impossible à plisser effaçant les rides et les reliefs. Cet aspect cutané se voit au cours de la sclérodermie qui est une maladie systémique avec une atteinte cutanée.

(16:13 - 16:35)

On arrive maintenant à l'analyse du groupement des lésions. La disposition des lésions peut être en placard à bord net comme dans les mycoses cutanées ou à bord immité ou du cours d'un eczéma de contact. On peut avoir une disposition linéaire le long d'un tragi-vasculaire chose qu'on peut voir au cours d'une fribite superficielle ou le long d'un métamer cutané ou du cours d'un zona.

(16:36 - 16:59)

Le contour des lésions peut être annulaire comme le cas d'un granulome annulaire ou polycyclique au cours d'un érythème figuré. On peut avoir un aspect en cocarde au cours d'un érythème polymorphe ou en bouquet au cours d'un herpès cutané. L'analyse de la topographie

des lésions présente toujours de l'intérêt qu'elles soient localisées ou diffuses, unilatérales, symétriques.

(17:00 - 17:40)

La présence de lésions sur le coude, le genou évoque un psoriasis. La présence de lésions sur les zones palmoplantaires évoque une syphilis secondaire. La présence de lésions uniques au niveau du muqueuse comme une érosion, des infections sexuellement transmissibles.

La présence de lésions sur les plis évoque un intertrigo mycosique ou autre. La présence d'un érythème sur une jambe évoque un éryzipel mais aussi une alopecie du scalp chez un enfant évoque une teigne. Il faut savoir que l'examen somatique complète l'examen cutané et on peut avoir recours à des investigations complémentaires déterminantes pour le diagnostic, par exemple des examens bactériologiques, mycologiques, histologiques.

(17:41 - 17:57)

Il faut savoir que la symbiologie cutano-muqueuse est capitale, que l'analyse des lésions élémentaires est importante. Aux étapes diagnostiques, bien sûr, la synthèse de tous les paramètres cliniques, la disposition et la topographie permettent les étapes diagnostiques. Je vous remercie.